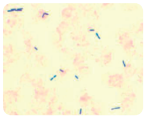
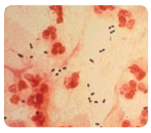
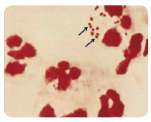
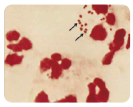
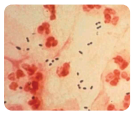
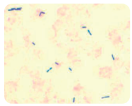
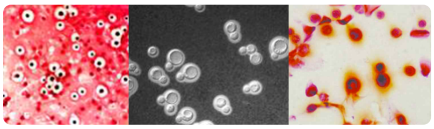
## @감염주의 모아보기

1. 기본주의는 손씻기만 있고, 마스크는 아니다.
2. 접촉주의는 장갑/가운(덧신은 틀린선지)이고, 1인실(or 코호트격리)이다.
3. 비말주의는 덴탈마스크 이고, 1인실(or 침상간 커튼)이다.
4. 공기주의는 음압격리/N95이고, 파결홍수 이다. (그냥 대상포진은 공기주의 아니지만, 그냥 수두는 공기주의 맞다)

## @형태에 따른 네임드균

- 음성막대: 녹농균, 클렙시엘라, EC
- 양성막대: 리스테리아
  - 
- 양성쌍알: 폐렴알균
  - 
- 음성쌍알: 임질&수막알균
  - 

## 뇌수막염

1. 뇌척수액 감염이 있어도, 경부강직이 없으면 진단명은 뇌염으로 바뀐다.
2. 신생아는 암피트리악손 / 소아~성인은 반코트리악손 / ≥50세는 반코암피트리악손
3. 원인균도 외워야 한다.
   - 신생아: "아갈리대장" : GBS(S.agal), 리스테리아(양성막대균), EC
   - 소아~성인: "폐경전 섹수막해" : 폐렴알균, 수막알균(N.menin)
   - ≥50세: "폐경하면 리스돼" 폐렴알균, 리스테리아(양성막대균)
4. 소아~성인 뇌수막염의 접촉자는 수막알균 예방위해 리팜핀 을 준다.
5. 원인균의 사진도 외워야 한다.
   - 수막알균(N.menin) = 음성쌍알균
     - 
   - 폐렴알균(S.pneu) = 양성쌍알균
     - 
   - 리스테리아 = 양성막대균
     - 
6. 사진보고 맞춰야하는 문제에서, 면역저하자라면 Cryptococcus(효모균증)이 함정문제로 나온다. 항원 검사(Ag test) 후에, 암포테리신 을 줘야한다.
   - 
7. 세균성 뇌수막염은 전부 다핵구>>림프구(+) 인데, 만약 그렇지 않다면 바이러스 수막염이다. Entero.virus 하고 HSV 중에 하나 고르면 된다.
   - 

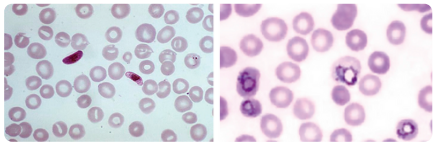
## 도관／의료 관련감염

1. 중심정맥관/주사 등 피부에 찌르는 것은 MRSA 감염이 흔하며, 반코/테이코/리네졸리드 로 치료해야 한다. 베타딘보다 헥시딘이 우월하다.
2. MRSA의 감수성검사는 의외로 메티실린이 아니라 옥사실린 으로 한다.

## 동남아_뎅기치쿤지카／티푸스

1. vector가 모기인 질환: 치쿤군야/지카/뎅기/황열
   - "모기 물린 치지카와가 노란 오뎅을 먹는다."
2. 동남아 질환: 치쿤군야/지카/뎅기/장티푸스&파라티푸스
   - 황열(아프리카/중남미 임)이 없고 장티푸스/파라티푸스가 추가됨
3. 장티푸스/파라티푸스는 체온이 올라도 심박수가 안오르는 relative bradycardia가 특징이다. 낚시선지로 Scrub typhus가 나오는데, 이건 쯔쯔가무시의 학명이고, Salmonella (para)typhi 가 정답이다.
4. 동남아에서 혈소판감소(+) 발진(+) 안구통(+) 이면 뎅기이다. "눈이 뎅기어요"
   - 

## 말라리아

1. 말초혈액펴바른표본으로 검사한다.
   - 
2. 열대면 P.falciparum 이고 아르테 주고, 국내는 P.vivax이고 클로로퀸 준다.
3. 말라리아 예방은, 아프리카는 메플로퀸, 동남아은 아토바퀸이다.

## 불명열

1. 다양한 약을 복용해도 열이 지속될 경우, 오히려 약 때문일 수 있어서 중단해봐야 한다.]
2. 체중감소(+)일 경우, 암/농양 모두 가능하고, CT를 찍어보면 된다.
3. 목덩이(+)일 경우, 무통성이고 2cm보다 크면 림프종이고, 그 반대면 키쿠치병(조직구.괴사성.림프절염)이어서 NSAID만 줘도 된다.
4. morning stiffness(+) CRP/ESR(+) 이어서 류마티스관절염인 줄 알았는데, CCP(-) 라면 류마티스다발근통이다. 스테로이드로 치료한다.
5. 열이 오를 때 발진이 나타난다고 무조건 열꽃인건 아니고, 관절통 여부를 꼭 확인해야 한다. 소아특발관절염이 성인에 나타난걸 성인형스틸병이라고 하고, 항핵항체/류마티스인자/B27 을 검사해야 한다.

## 호중구감소성 발열

1. 항암치료를 받는 환자가 열이난다면 루틴하게 백혈구×호중구분율<500 인지 확인해야한다. 바로 항녹농균 항생제 들어가야함.

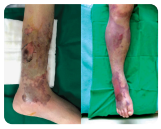
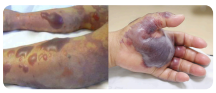
## 매독／임질

1. 우연히발견된 무통성 궤양이면 매독을 의심하고, 선별검사(혈청검사) 한뒤, 양성이면 확진검사(항체검사)를 한다.
   - 
2. 혈청검사(VDRL/RPR)와 항체검사(FTA-ABS/TPHA)가 있는데, 항체검사는 한번 걸리면 평생 양성이라, 추적검사로 못 쓴다. 그래서 선별/추적 검사 모두 혈청검사로 이루어진다.
3. 항체검사 양성이면 페니실린 1회 준다.
4. 혈청검사 역가 ≥ 1:32 면 뇌척수액검사를 한다.
5. 남자의 요도분비물도, 여자랑 똑같이 임클 을 동시에 상정하고 아지트리악손 을 준다.

## 후천성면역결핍증

1. HIV 의심되면 ELISA → 웨스턴블롯 → 즉시 3제요법(엠트리/테노/빅테)
2. 주사찔림이면 즉시 ELISA → 즉시 3제요법 (ELISA 결과를 기다리지 않음)

## 괴사근막vs비브리오

1. 괴사근막/비브리오 사진이 헷갈린다면 바닷가/회(+) 피물집(+) 있는 쪽이 비브리오이다.
2. 괴사근막염은 괴사조직제거 하고, 광범위절개해서 구획증후군 예방한 다음, 혐기균커버(술클클) 한다.
   - 
3. 비브리오는 그람음성이므로 Cipro탁심 주는데, 비브리오만 특이하게도 독시에 잘들어서, 독시트리악손을 더 많이 쓴다.
   - 

## 연조직염vs단독vs결절홍반

1. 연조직염과 단독은 치료는 세파졸린으로 같지만, 원인균은 다르다. 단독은 포도알균이 아니라 A군사슬알균(S.pyogenes)임. 둘다 다리에 생기면 구분하기 힘들 수 있는데, 좀더 부은 쪽이 연조직염, 경계분명/울퉁불퉁 한쪽이 단독이다.
2. 결절홍반도 다리를 빨갛게 만든다.
   - 

## 예방접종_성인

1. 의료인은 5가지(T독홍수B)를 받아야하는데, 수B는 항체있으면 필요없다.
2. 임신부는 T독 을 받고, 생백신은 금기이다.
3. 무비증은 수막구균/폐렴구균/헤모필루스 를 맞아야하고, 기숙사/신병은 수막구균 만 맞아도 된다. 수막구균은 필수접종이 아님을 알아야 한다.
4. 폐렴구균은 이전에 뭐를 맞았든, 무조건 단백 20/21 중에 하나를 새로 맞아야 하는걸로 바꼈다. 예외는 단백15+다당23 뿐이다.
5. 50세 이상은 대상포진 맞아야함.

## 예방접종_소아

1. 필수암기
   - 태어나면 BCG + B형간염 → 이후 1,6개월에 B형간염.
   - 12~15개월 → A폴홍수폐헤
   - 4~6세 → D폴홍
2. 원칙
   - 생백신(BCG, 홍역, 수두): 동시접종은 되는데 따로한다면 ≥4주간격
   - 면역글로불린(가와사키 치료 등) → 생백신 최소간격=11개월
   - 자의로 먼저 맞음 → 노카운트하고 예정대로 다시 접종 (esp.홍역)
   - 무비증 → 나이 상관없이 폐렴 추가접종(뇌수막염 예방)
3. "오늘 접종가능한 백신은?" 이라고 물으면 아래 선지를 모두 배제한다.
   - 생백신/면역글로불린 간격 안 맞는 것
   - 애초에 지금 나이에 맞을 백신이 아닌 것
4. 기타
   - 일반인에서 B형간염 항체 음전은 추가접종 필요 없다.

## 예방접종_접촉자

1. Td=Tdap=파상풍백신=파상풍독소 모두 같은 말로 알고 풀면 된다. 대신 DTap은 틀린선지
2. 5년이내 맞았으면 경과관찰한다. 소아 예방접종 모두 맞았다고 한다면, 17세 까지는 괜찮다고 외우면 된다(12세에 마지막으로 맞으므로). 단, 접종여부를 모른다고 하면 필수접종이니까 맞았겠거니 하면 안되고, 안맞았은걸로 취급한다.
3. 경과관찰 대상이 아니라면 Td(=Tdap=파상풍백신=파상풍독소) 맞으면 되고, 상처가 더러우면 면역글로불린 까지 추가한다.

## 예방접종_해외여행

1. 필수접종은 아프리카/중남미의 황열 과, 사우디 메카의 수막알균 뿐이다. 지역은 알아야 한다.
   - 아프리카: 케냐/탄자니아)
   - 중남미: 브라질/페루/볼리비아
2. 동남아/인도 등 저개발국가는 A형간염/장티푸스 맞는걸 권고한다.
3. 말라리아는 예방약물은 있지만 백신이라고 부르지 않는다.
4. 답이 파상풍백신일 때도 많다. 평생 10년마다 맞아야 하는 백신이라, 선지에 있으면 무적이다.

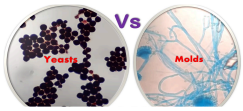
## 인플루엔자/코로나

1. 코로나 경증은 팍스로비드(니르마/리토나) 주고, 중증(ARDS급)은 산소+스테로이드+바리시/토실리 준다.
2. 인플루엔자는 오셀/자나/페라/발록 주는데, 자나는 흡입제제라서 천식/COPD 금기이고, 페라는 IV라는 장점이 있다. 바록은 오셀 내성일 때 사용한다.

## 쯔쯔/혈소판감소/혈뇨/렙토

1. 진드기 물림이 있다면, 일단 혈소판을 본다. 정상이면 Scrub typhus 라서 아지/독시 주고, 혈소판감소면 중증열성혈소판감소 바이러스라서 경과관찰한다.
   - 
2. 결막출혈이 있다면, 일단 혈뇨 를 본다. 정상이면 렙토스피라증 이라서 아지/독시 주고, 혈뇨 있으면 신증후군출혈열 바이러스라서 경과관찰한다.
   - 

## 칸디다

1. 진균은 형태에 따라 yeast(효모형)과 mold(사상형/곰팡이형)으로 나눈다.
   - 

2. 혈액배양에서 yeast가 보고되었는데, β-D-glucan이 양성이라면 칸디다이니, 카스포펀진/미카펀진을 주고(낚시선지로 플루코나졸이 나온다), 음성이라면 크립토코쿠스이니, 항원검사를 하고 암포테리신 을 준다.
3. 혈액배양에서 mold가 보고되었다면 아스퍼길루스이니 보리코나졸 준다.

## 항생제 부작용

1. 반코 주다가 전신이 붉어져도, 호전되면 다시 투여한다.